

Manual de AVC Isquêmico

Corpus didático ampliado com IA. Não é diretriz clínica validada nem orientação de tratamento.

Frase de contexto original

O acidente vascular cerebral isquêmico agudo deve ser tratado com trombolíticos venosos em até quatro horas e meia do início dos sintomas.

Reconhecimento e avaliação urgente

O acidente vascular cerebral isquêmico ocorre quando a circulação para uma região do cérebro é obstruída. Este manual apresenta o contexto da avaliação urgente e da seleção para tratamento de reperfusão. A expressão derrame cerebral é frequente na linguagem cotidiana, mas não distingue o AVC isquêmico do hemorrágico. [1] O atendimento investiga rapidamente a natureza do evento e as opções de tratamento. Exames de imagem ajudam a identificar se há sangramento ou obstrução e orientam as decisões. O tempo de início dos sintomas, ou o último momento em que a pessoa estava bem, é uma informação central para a equipe. [1]

Significado da janela de quatro horas e meia

A frase de contexto não representa uma indicação universal. Na diretriz de 2026, a trombólise intravenosa com alteplase ou tenecteplase é uma opção para pacientes elegíveis, com déficits incapacitantes, dentro da janela de 4,5 horas. A equipe verifica os critérios clínicos e as contraindicações antes de administrar o tratamento. [2] O objetivo é tratar o paciente elegível o mais cedo possível. A existência de uma janela não significa aguardar seu limite. Há também situações selecionadas de início desconhecido ou janela ampliada nas quais critérios de imagem podem permitir trombólise. Esses casos exigem avaliação especializada e não podem ser decididos apenas pelo horário. [2]

Registro do tempo

O prontuário deve distinguir horário de descoberta dos sintomas, início conhecido e último momento sem alterações. Se o início for incerto, a incerteza precisa permanecer explícita. Substituir um horário desconhecido por uma estimativa não confirmada pode distorcer a interpretação do atendimento.

Manual de AVC Isquêmico

Corpus didático ampliado com IA. Não é diretriz clínica validada nem orientação de tratamento.

Reperusão e acompanhamento

A trombólise utiliza medicamento para dissolver o coágulo. A trombectomia é um procedimento para removê-lo e pode ser indicada em pacientes selecionados com oclusão de grandes vasos. As opções são avaliadas conforme exames, características do evento e elegibilidade, dentro da organização da rede de atendimento. [1, 2] Nem todo déficit neurológico dentro de 4,5 horas leva à trombólise. A diretriz diferencia apresentações incapacitantes de déficits não incapacitantes e aborda escolhas específicas para esses grupos. Assim, a frase original funciona como uma síntese do tema, enquanto a decisão depende da avaliação completa. [2]

Exemplo fictício de linha do tempo

Uma pessoa é vista sem alterações às 8h00 e, às 8h20, um familiar percebe dificuldade para falar e movimentar um braço. No atendimento, os dois horários são registrados com a indicação de quem forneceu a informação. O caso é encaminhado à avaliação de AVC e à investigação por imagem. O registro não presume que a observação do familiar determine, por si só, o tratamento. A equipe documenta os achados, a elegibilidade e a decisão tomada. Se houver transferência, a linha do tempo acompanha o paciente para que o serviço de destino compreenda quais informações foram confirmadas e quais permanecem incertas.

Comunicação entre equipes

Um resumo útil apresenta o déficit observado, a evolução, os horários e os exames realizados. A expressão AVC isquêmico agudo deve permanecer distinta de suspeita de AVC até a avaliação diagnóstica correspondente. Termos como trombólise venosa, reperusão e trombectomia precisam indicar procedimentos diferentes, embora relacionados ao restabelecimento da circulação cerebral.